

PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NO REQUIEREN SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE

En general, en los procedimientos quirúrgicos considerados de bajo riesgo hemorrágico **NO** se recomienda suspensión del tratamiento anticoagulante con antivitamina K (acenocumarol, warfarina) o anticoagulantes de acción directa (dabigatran, rivaroxaban, edoxaban, apixaban).

En el caso de cirugía oral o maxilofacial de moderado o alto riesgo de sangrado, seguiremos las recomendaciones según protocolo Distrito Córdoba-Guadalquivir y Hospital Reina Sofía teniendo en cuenta también el riesgo de sangrado del paciente y el riesgo tromboembólico. Sólo en pacientes de alto o muy alto riesgo tromboembólico, está aceptado utilizar heparina de bajo peso molecular durante la fase de suspensión.

SE CONSIDERAN PROCEDIMIENTOS DE BAJO RIESGO DE SANGRADO ENTRE OTROS:

- ✓ Exploración dental
- ✓ Exploración **periodontal** (sondaje, profilaxis “limpieza”, raspados y alisados “curetajes”)
- ✓ **Exodoncia** simple (1-2 piezas)
- ✓ **Radiografía** (panorámica, periapical)/sialografía/artograma de articulación temporo-mandibular
- ✓ Procedimientos de odontología restauradora: obturaciones (**empastes**), reconstrucciones, incrustaciones, inlays, onlays, carillas.
- ✓ Procedimientos de prostodoncia: **prótesis** fija («coronas o puentes) o removible («dentaduras»)/ prótesis maxilofacial
- ✓ **Ortodoncia/endodoncia**
- ✓ Tratamiento de conductos
- ✓ Cirugía apical o apicectomías
- ✓ Resecciones radiculares quirúrgicas
- ✓ **Procedimientos de Cirugía oral o Maxilofacial:**

- ✓ Alveoloplastia / vestibuloplastia/excisión de tejidos blandos/Frenectomía/ Extirpación de tumoraciones o quistes (excepto malignos intraóseos > 1,25 cm)
- ✓ Cirugías periodontales resectivas, regenerativas o mucogingivales.
- ✓ **Procedimientos con implantes dentales** (colocación convencional de implantes. técnica de regeneración simultáneas o diferidas a la colocación de los implantes)

PAUTA DE SUSPENSIÓN DE ANTICOAGULANTES



✓ PARA ANTICOAGULANTES ANTAGONISTAS DE VITAMINA K

Días hasta la cirugía X = última dosis de ACO		-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
Acenocumarol Warfarina	7 días antes INR < 2			X Warfarina		X Acenocumarol		Control INR preoperatorio	Cirugía procedimiento
	7 días antes INR 2-3		X Warfarina		X Acenocumarol			Control INR preoperatorio	Cirugía procedimiento
	7 días antes INR > 3	X Warfarina		X Acenocumarol				Control INR preoperatorio	Cirugía procedimiento

La X indica el último día que ha de tomar la medicación antes del procedimiento

✓ PARA ANTICOAGULANTES DE ACCIÓN DIRECTA

Días hasta la cirugía X = última dosis de ACO		-5	-4	-3	-2	-1	0
Dabigatrán	Riesgo hemorrágico bajo		X (CICr < 50)	X (CICr 50-79)	X (CICr ≥ 80)		Cirugía procedimiento
	Riesgo hemorrágico medio-alto	X (CICr < 50)	X (CICr 50-79)	X (CICr ≥ 80)			Cirugía procedimiento
Rivaroxabán Apixabán Edoxabán	Riesgo hemorrágico bajo			X (CICr 15-30)	X (CICr ≥ 30)		Cirugía procedimiento
	Riesgo hemorrágico medio-alto		X (CICr 15-30)	X (CICr ≥ 30)			Cirugía procedimiento

La X indica el último día que ha de tomar la medicación antes del procedimiento

PROFILAXIS DE SANGRADO

En caso de limpieza bucal:

1. Será suficiente con los enjuagues con ácido tranexámico (AMCHAFIBRIN®-500 mg, 5 ml), durante el procedimiento y tras éste, mientras dure el sangrado.
2. Recuerde la eventual necesidad de efectuar profilaxis de endocarditis bacteriana según la recomendación de su cardiólogo.

En caso de extracción dental:

1. Tras la extracción dentaria se irrigará la zona cruenta con el contenido de una ampolla de ácido tranexámico (AMCHAFIBRIN®-500 mg, 5 ml). Seguidamente el paciente realizará una compresión activa sobre la zona (mordida-taponamiento) con el contenido de una segunda ampolla impregnando una gasa hasta que se constituya físicamente el coágulo (20 minutos aproximadamente).
2. Posteriormente se efectuarán enjuagues muy suaves con el mismo producto durante 2-10 minutos cada 6 horas, sin tragarlo (mínimo 2 días) sin comer ni beber en la hora siguiente. Prolongar su uso hasta que cese el sangrado (incluso una semana).
3. El primer día elegir alimentos líquidos y fríos que tomará sin succión. Evitar alimentos duros, cortantes o calientes y la succión que supone fumar. hasta el tercer día no masticar en ese lado.
4. Se atenderá a los analgésicos y antiinflamatorios recomendados en la unidad de control del TAO (tipo paracetamol).
5. La probabilidad de un sangrado posterior rebelde es baja; si aparece impregnará una gasa en AMCHAFIBRIN® y efectuará una mordida durante 30 minutos. Si no cediese el sangrado puede requerir taponamiento y sutura en un medio especializado.

BIBLIOGRAFÍA

1 Vivas D et al. Vivas D et al. Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: documento de consenso de SEC, SEDAR, SEACV, SECTCV, AEC, SECPRE, SEPD, SEGO, SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEPAR, SENEC, SEO, SEPA, SERVEI, SECOT y AEURev Esp Cardiol. 2018;71(7):553-564

2 Douketis J, LypG. Perioperative management of patients receiving anticoagulants. UpToDate 2018

3 Recomendaciones adoptadas del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, Servicio de Referencia de Cirugía Maxilofacial y de la Sociedad Aragonesa de Hematología y Hemoterapia (SAHH).

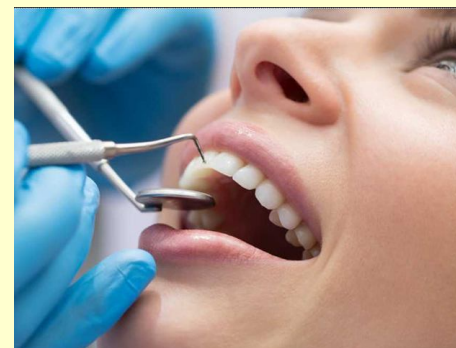
4.-POE – Seguimiento INR –DSCorGu_001 V-5 Sep 22



Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR

Recomendaciones para procedimientos de odontología en pacientes anticoagulados



Comisión de seguridad del paciente Distrito Sanitario
Córdoba-Guadalquivir
UGC Hematología Reina Sofía
UGC Odontología Distrito Sanitario